PHÒNG CHỐNG Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG VÀ DỊCH BỆNH DO THẢM HỌA

Mục tiêu

1. Trình bày được khái niệm thảm họa và phân loại thảm họa
2. Trình bày được nội dung công tác chuẩn bị xử lý vệ sinh môi trường tại các tuyến trước thảm họa bão lụt.
3. Trình bày được các biện pháp xử lý nước và vệ sinh môi trường trước, trong và sau thảm họa bão lụt.
4. Trình bày được các biện pháp phòng chống một số dịch bệnh sau thảm hoạ

TÀI LiỆU THAM KHẢO

- Hà Văn Như, Nguyễn Huy Nga, Lê Danh Tuyên (2011), *Quản lý y tế công cộng trong thảm họa*. Nhà xuất bản Y học 2011.
- Bộ Y tế (2012), *Thực hành kỹ thuật môi trường*. Nhà xuất bản Y học
- Quyết định số 255/2006/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược Quốc gia Y tế dự phòng Việt Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020
- Khung hành động Hyogo của Tổ chức Y tế thế giới giai đoạn 2005- 2010

1. KHÁI NIỆM THẢM HỌA

1.1. Định nghĩa thảm họa:

Là những hiện tượng, biến cố bất ngờ gây tổn thất lớn về người và của vượt quá khả năng tự bù đắp của địa phương nơi xảy ra thảm họa.

1.2. Về y tế, các thảm họa thường gây ảnh hưởng lớn đến con người như tổn thất về sinh mạng, bị thương, bị bệnh, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, đòi hỏi sự đáp ứng y tế khẩn cấp.

Khái niệm thảm họa

❖Một thiên tai hoặc thảm hoạ nhất thiết phải hội đủ một số tiêu chuẩn sau:

* Ít nhất có 10 người chết trở lên hoặc ít nhất có trên 100 người bị ảnh hưởng
* Môi trường bị tàn phá hoặc bị ô nhiễm nặng nề
* Tuyên bố tình trạng khẩn cấp của quốc gia
* Kêu gọi sự giúp đỡ của quốc tế

1.3. Bộ Y tế quy định mức độ thảm họa (theo số nạn nhân)

+ Mức 1: 30-100 nạn nhân /20-50 nhập viện.
+ Mức 2: 101-500 nạn nhân /51-200 nhập viện).
+ Mức 3: 501-2000 nạn nhân /201-300 nhập viện.
+ Mức 4: trên 2000 nạn nhân /trên 300 nhập viện.

1.4. Phân loại thảm họa:

- Do thiên nhiên: do những biến đổi bất thường về khí tượng, về địa lý và sinh thái: bão, lụt, động đất, núi lửa, sóng thần, nóng bức, lạnh, hạn hán, lở đất….

1.4. Phân loại thảm họa

- Thảm họa do con người gây ra bao gồm:

- Các tai nạn công nghiệp.
- Các tai nạn giao thông.
- Các tai nạn xây dựng - kiến trúc.
- Thảm họa do phá hoại môi trường, gây ô nhiễm nặng môi trường sống
- Thảm họa do bệnh dịch (các dịch bệnh tối nguy hiểm, các đại dịch).
- Thảm họa do các yếu tố xã hội - chính trị - kinh tế.

2. Công tác chuẩn bị xử lý vệ sinh môi trường tại các tuyến trước thảm họa

Tuyến tỉnh

1. Ban chỉ huy PCTH cần thành lập nhóm phối hợp liên ngành: Nông nghiệp PTNT - Tài nguyên & Môi trường - Y tế. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị chuẩn bị vật tư, kinh phí, cơ số thuốc, tổ chức huấn luyện cho tuyến dưới.
2. Có kế hoạch tổ chức, hướng dẫn thu gom và xử lý rác thải, nước thải, xác súc vật chết, cung cấp nước sạch, phòng bệnh dịch và quản lý ô nhiễm trong vùng thiên tai, thảm hoạ.
3. Cần đánh giá và dự báo thảm hoạ, các vấn đề môi trường liên quan và khả năng đáp ứng

Công tác chuẩn bị của tuyến cơ sở

1. Ban chỉ huy PCTH phân công cán bộ phụ trách, xây dựng kế hoạch phòng chống dịch bệnh và quản lý ô nhiễm theo khu vực dân cư, khu tập kết chất thải rắn.
2. Tổ chức thành các tổ, đội xung kích hoặc “đội thanh niên tình nguyện xanh” để sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ theo sự chỉ huy thống nhất.
3. Tiểu ban PCTH của địa phương cần tổ chức huấn luyện, tập dượt cho các đội chuyên trách này.

Công tác chuẩn bị của tuyến cơ sở

4. Kiểm tra, nắm tình hình các cơ sở kinh doanh, dự trữ hoá chất bảo vệ thực vật và dự kiến phương án phòng chống ô nhiễm môi trường do hoá chất phát tán theo nước lũ.
5. Lập sơ đồ dự kiến địa điểm sơ tán, khu vực tập kết, xử lý rác, khu vệ sinh, chôn súc vật chết, bãi chôn tử thi và công bố rộng rãi, tránh ô nhiễm môi trường.
6. Tìm nguồn nước để quản lý, bảo vệ và dự trữ nước uống khi xảy ra thảm hoạ

Công tác tuyên truyền, giáo dục tại cộng đồng

- Phổ biến rộng rãi thông tin về các dịch vụ y tế môi trường sẵn có như hoá chất xử lý nước, xử lý vệ sinh môi trường, địa chỉ liên hệ và phương thức cung cấp.
- Truyền thông giáo dục cộng đồng xoá bỏ các khu vực sinh trưởng của các vector truyền bệnh.
- Giáo dục các biện pháp đề phòng dịnh bệnh lây truyền và vệ sinh cá nhân.

Đối với người dân

1. Dự trữ lương thực, thực phẩm, chất đốt
2. Chuẩn bị một số thuốc thông thường như thuốc tiêu chảy, cảm sốt, dầu xoa, thuốc đau mắt, bông băng, thuốc đỏ, thuốc ngoài da,...
3. Gia cố nhà cửa
4. Chuẩn bị phao, thuyền, ghe (nếu có).

3. Xử lý nước và vệ sinh môi trường

3.1. Công tác chuẩn bị trước mùa lũ lụt

3.1.1. Với các nguồn nước:

1. Chuẩn bị nắp và ny-lông để bịt miệng giếng khơi hoặc nút miệng giếng khoan.
2. Bịt miệng giếng trước khi sơ tán hoặc khi thấy có nguy cơ giếng bị ngập.
3. Nơi có nước máy phải dự trữ nước trong các bể lớn ở trên cao.
4. Dự trữ nước sạch cho gia đình, dự báo và diễn tập tình huống mất nước máy

3.1.2. Với nhà tiêu và chuồng gia súc:

1. Nhà tiêu hai ngăn: Lấy hết phân ra, đào hố ủ lèn chặt đất, mỗi ngăn đổ 2 - 3 kg vôi bột, chuẩn bị sẵn nắp đậy lỗ đi tiêu.
2. Nhà tiêu tự hoại hoặc thấm dội nước: chuẩn bị nút bệ xí.
3. Nhà tiêu đào: lấp một lớp đất dày khoảng 0,5m, lèn chặt.
4. Chuồng gia súc: lấy hết phân ra ủ, rắc 2 - 3 kg vôi bột. Đồng thời dời chuồng gia súc đến nơi đất cao.

3.1.3. Đối với y tế

1. Kiểm tra, hướng dẫn các vùng trọng điểm xử lý phân, rác và nước thải. Kiểm soát nguồn nước sinh hoạt.
2. Theo dõi, giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh, chủ yếu là các bệnh đường tiêu hoá, bệnh truyền qua trung gian.
3. Chuẩn bị sẵn các cơ số thuốc chủ yếu là kháng sinh, thuốc đường tiêu hóa có thể đáp ứng cho 2000 dến 4000 người và phân phối đến các Đội YTDP và trạm Y tế xã.

3.1.3. Đối với y tế

4. Chuẩn bị hoá chất xử lý nước, tài liệu hướng dẫn:
   - Phèn chua
   - Cloramin B bột 25%
   - Cloramin B viên 0,25g.
   - Tài liệu hướng dẫn xử lý nước
5. Chuẩn bị hoá chất diệt côn trùng và xử lý môi trường (*do Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh, thành phố hoặc Đội Y tế dự phòng quản lý và sử dụng, không phát cho trạm y tế xã và hộ gia đình).*

- Chuẩn bị vôi bột, Deltamethrin, hóa chất nhóm Pyrethroid…
- Trang bị bình bơm

Lưu ý:

Phát các loại hoá chất dạng viên cho các hộ gia đình ngay trước khi bão lụt xảy ra.

Hoá chất bột do Trung tâm Y tế huyện hoặc trạm y tế xã giữ để sử dụng sau khi nước rút.

3.2. Xử lý nước ăn uống và vệ sinh môi trường trong và sau khi ngập lụt

3.2.1. Xử lý các giếng nước ăn, uống sinh hoạt sau ngập lụt.

a, Giếng khơi

Quy trình xử lý nước được tiến hành theo 3 bước sau:

- Bước 1: Thau rửa giếng
- Bước 2: Làm trong nước giếng
- Bước 3: Khử trùng nước giếng

Xử lý các giếng nước ăn, uống sinh hoạt.

Bước 1: Thau rửa giếng

- Khơi thông tất cả các vùng nước xung quanh khu vực giếng.
- Tháo bỏ nắp ni long bịt giếng
- Thau vét giếng, dùng nước giếng dội lên thành, sân giếng.

3.2.1. Xử lý các giếng nước ăn, uống sinh hoạt.

- **Bước 2**: **Làm trong nước**

- **Dùng phèn chua** liều lượng là 50g/1 m3 nước, nếu nước đục nhiều có thể cho lượng phèn tối đa là 100g/1m3 nước.
- Hoà tan hết lượng phèn cần thiết vào một gầu nước, tưới đều lên giếng nước, thả gầu chìm sâu xuống nước rồi kéo mạnh lên khoảng 10 lần, để từ 30 phút đến 1 giờ cho cặn lắng xuống hết.

3.2.1. Xử lý các giếng nước ăn, uống sinh hoạt

- **Bước 3**: Khử trùng giếng nước:

- nguyên tắc nước giếng sau khi khử trùng phải có nồng độ Chlor thừa là 0,5-1,0mg/lít (có mùi nồng của Chlor).
- Có thể dùng một số hoá chất khác như: Chlorua vôi 20% (13g/m3) hoặc Chlorua vôi 70% (4g/m3).
- Múc một gầu nước, hòa lượng hóa chất trên vào, khuấy cho tan hết. Tưới đều gầu này vào giếng. Thả gầu cho chìm sâu đến nửa cột nước, kéo lên xuống khoảng 10 lần. Nếu không thấy mùi chlor, cho thêm hóa chất dần đến khi có mùi chlor.
- Dùng nước này dội thành giếng để khử trùng, để khoảng 30 phút mới dùng.
- Đun sôi mới được uống.

3.2.1. Xử lý các giếng nước ăn, uống sinh hoạt

b, Giếng khoan

- Bơm hết nước đục, bơm tiếp 15 phút, bỏ nước đi, sau bước này có thể sử dụng
- Cần chú ý làm vệ sinh bơm, sàn giếng

3.2.2. Xử lý nước ngập để phục vụ ăn uống và sinh hoạt

a. Làm trong nước

- Dùng phèn chua với liều lượng 1g phèn chua cho 20 lít nước.
- Múc một gáo nước, hoà lượng phèn tương ứng thể tích nước cần xử lý cho tan hết; cho vào chum, vại hay thùng, khuấy đều, chờ khoảng 30 phút cho cặn lắng hết rồi gạn lấy nước trong.

a. Làm trong nước

Nếu không có phèn chua:

- Lọc cát tạm thời bằng một thùng, xô, vại thể tích khoảng 20-30lít.
- Đục một lỗ đường kính 1cm trên thành cách đáy thùng 5cm, cho một ít đá hoặc gạch vỡ lót ở đáy, đặt một mảnh bao tải gai lên trên rồi đổ cát dày khoảng 25-30cm.
- Đổ nước giếng vào cho đến khi nước chảy ra trong thì lấy để khử trùng.
- Dùng vải sạch để lọc, làm vài lần cho đến khi được nước trong.

b. Khử trùng bằng hoá chất

- **<u>Khử trùng bằng viên Cloramin B 0,25g:</u>**

- Rất tiện lợi cho khử trùng các thể tích nước nhỏ như chum, vại, bể chứa nước nhỏ.
- Một viên Cloramin B dùng để khử trùng 25 lít nước.

b. Khử trùng bằng hoá chất

- **<u>Khử trùng bằng bột Cloramin B:</u>**

Tính lượng hoá chất cần thiết để khử trùng, nồng độ yêu cầu là 10mg/lít.

Ví dụ: để khử trùng một thùng nước 30 lít thì cần 0,3g Cloramin B 25%. Có thể dùng thìa canh để đong bột hoá chất khử trùng, mỗi thìa canh đầy tương đương 10g. Như vậy để khử trùng 300 lít nước cần khoảng 1/3 thìa bột Cloramin B.

b. Khử trùng bằng hoá chất

Cách khử trùng: Hòa tan lượng hóa chất cần thiết vào một gáo nước rồi đổ vào bể chứa, trộn đều. Ngửi, nếu chưa có mùi Chlor, thêm hóa chất dần đến khi có mùi chlor. Múc nước tưới lên bể chứa để tiệt khuẩn. Để 30 phút.

Quy trình xử lý nước uống

Làm trong nước bằng phèn chua; vải, màn → **Khử trùng bằng Cloramin** → **Đun sôi** → **Uống**

3.2.3. Xử lý rác trong khi ngập lụt

- Đối với lán trại nơi nhân dân sơ tán:

- Đào các rãnh có chiều rộng 1m, dài 1,5m; sâu 2m. Mỗi ngày rắc một lớp đất lên mặt rác. Dùng hố này cho 200 người/tuần, sau lấp bằng đất dày 40cm.
- Nếu có điều kiện: Cung cấp các thùng đựng rác, thể tích 50-100l cho 12-25 người. Đầy thùng đem chôn, hoặc đốt..
- Nếu ngâp lụt kéo dài, tổ chức ghe thuyền đến từng nhà thu gom rác.

3.2.4. Xử lý phân trong sinh hoạt khi ngập lụt

a. Xử lý phân người

1. Tận dụng những chỗ đất cao, không bị ngập, đào những hố nhỏ mỗi chiều 0,5m làm hố tiêu tạm thời cách xa nhà ở, nguồn nước ≥50 m để hạn chế sự phát tán mầm bệnh.
2. Nơi nước ngập không kịp sơ tán hoặc bắt buộc phải ở lại nơi ngập lụt → xử lý tạm thời bằng các phương tiện có sẵn (thùng, chậu, rổ, giá hỏng đổ tro, trấu, mùn cưa hoặc đất), đi cầu vào đó rồi treo phía ngoài nhà ở, chờ khi nước rút đem ra chôn.

b. Xử lý phân gia súc, gia cầm

- Phân gia súc, gia cầm phải được chôn hàng ngày ở chỗ đất cao chưa ngập lụt, cách xa nhà ở, nguồn nước trên 50m. Trước khi lấp, rắc vôi bột để khử trùng.
- Ở nơi không có chỗ chôn, cầm tập trung, xử lý bằng vôi bột và dùng bao kín để nơi đất cao, lấy túi nilon bọc kín để tránh ruồi và mùi hôi, chờ khi nước rút đem chôn.

3.2.5. Quản lý gia súc, gia cầm và xử lý xác gia súc, gia cầm trong khi ngập lụt

- Quản lý gia súc, gia cầm chặt chẽ. Không thả gia súc, gia cầm để tránh ô nhiễm môi trường.
- Làm sạch chuồng trại và tẩy uế hàng ngày bằng các loại hóa chất khử trùng vôi bột, cloramin.
- Nếu có biểu hiện mắc bệnh phải cách ly hoặc tiêu hủy đúng quy định.

3.2.6. Xử lý môi trường

- Nước rút đến đâu các gia đình làm vệ sinh nhà cửa và huy động cộng đồng làm vệ sinh môi truờng đến đó ⟹ đẩy phù sa từ nhà, sân, đường đi.
- Khi nước rút hết, môi trường ô nhiễm nặng nề do xác súc vật, côn trùng, cây cối thối rữa. Cần khơi thông cống rãnh, lấp vũng nước đọng, chôn lấp xác súc vật chết, và tẩy uế.

3.2.6. Xử lý môi trường

- Dọn dẹp vệ sinh nhà cửa, phơi khô quần áo, không treo mắc quần áo ẩm ướt vào một chỗ dễ làm nơi trú ẩn cho muỗi.
- Làm vệ sinh và tu sửa nhà tiêu (nếu không hỏng nặng). Nếu hỏng nặng, chọn nơi cao ráo xa nhà, xa giếng (≥20m) đào hố tạm trong khi chờ xây mới (*chú ý lấp đất, tránh ruồi, côn trùng và súc vật).*
- Tiến hành sớm các biện pháp diệt côn trùng và trung gian truyền bệnh.

4. Xử lý tử thi, xác súc vật chết

4.1. Công tác chuẩn bị trước khi ngập lụt

- Khảo sát và bố trí địa điểm dự phòng nơi chôn cất tử thi và xác súc vật chết. Các tiêu chuẩn lựa chọn:

- Nơi cao ráo, cao hơn mức nước lịch sử của địa phương.
- Cách xa nguồn nước (mặt, ngầm), xa khu dân cư, trường học, cơ sở y tế.
- Đủ rộng để có thể chôn cất khi có tử vong hàng loạt
- Dễ dàng đi lại, vận chuyển trong mùa mua lũ.

- Chuẩn bị đầy đủ cơ số hóa chất khử trùng, vôi bột, trang thiết bị bảo hộ, phương tiện vận chuyển tử thi.
- Bố trí đội lưu động vận chuyển và chôn cất tử thi.

4. Xử lý tử thi, xác súc vật chết

4.2. Trong và sau khi ngập lụt

4.2.1. Đối với tử thi

- Người chết phải được đưa đến chôn nơi đất cao đã bố trí trước và phải đánh dấu để tìm lại.
- Trường hợp phải chôn nơi có nguy cơ ngập nước phải cho vào bao nilon kín, lèn hoặc buộc đá nặng lên quan tài.
- Tử thi đã bốc mùi hoặc phân hủy, phải xử lý bằng hóa chất sát trùng và phải được bao gói kín tránh ô nhiễm môi trường.
- Nơi có hỏa táng, chuyển đến hỏa táng nhanh nhất

4. Xử lý tử thi, xác súc vật chết

4.2.2. Xử lý xác súc vật chết

- Khảo sát sơ bộ để ước lượng số lượng xác súc vật chết cần xử lý.
- Vị trí chôn xác súc vật: tốt nhất là chôn ở ngoài đồng, xa các nguồn nước (ao, sông, hồ...) ít nhất 50m. Có thể chôn xác súc vật ở trong vườn nhưng cần lưu ý là phải cách xa các giếng nước ≥30m và phải xử lý kỹ bằng hoá chất khử trùng tẩy uế.

4.2.2. Xử lý xác súc vật chết

- Đào hố chôn sao cho tất cả xác súc vật được vùi sâu dưới đất ≥ 0,8m.

  Chuyển toàn bộ xác súc vật vào hố, cần hớt một lớp đất khoảng 10cm chỗ xác súc vật nằm chôn cùng với súc vật.

  Tốt nhất là đổ 2 - 3 kg vôi bột hoặc phun dung dịch hoá chất khử trùng, tẩy uế nồng độ cao (có thể tới 100mg/l Cloramin B 25%) lên trên rồi lấp đất, lèn chặt.

  Cắm biển báo hiệu nơi chôn xác súc vật để tránh bị đào bới.

4.2.2. Xử lý xác súc vật chết

- Hàng ngày phải kiểm tra nơi chôn xem có bị súc vật hoặc chuột bọ đào bới hay không. Nếu phát hiện có mùi hôi thối hoặc bị đào bới thì phải lấp lại và rào chắn.
- Khử trùng nơi có xác súc vật:

- phun thuốc khử trùng hoặc rắc vôi bột vào chỗ xác súc vật đã chuyển đi chôn
- tập trung rác vào chỗ đó và đốt (nếu không có vôi và thuốc khử trùng).

5. DỊCH BỆNH SAU THẢM HỌA

1. DO TÁC NHÂN TRONG NƯỚC: Tiêu chảy, Tả, Lỵ trực trùng….
2. DO VECTOR TRONG NƯỚC: sốt rét, sốt xuất huyết, VNNB
3. DO TIẾP XÚC: đau mắt đỏ, viêm da, viêm đường hô hấp cấp…

5.1. Các dịch bệnh do tác nhân trong nước và do tiếp xúc

+ Các bệnh tiêu chảy do nhiễm khuẩn (E.coli, Shigella, Salmonella…), do ký sinh trùng (Entamoeba histolytica…), do vi rút (Rotavirus, Enterovirus…), do nấm (Candida Albicans).
+ Đau mắt đỏ.
+ Bệnh ngoài da.
+ Các bệnh viêm nhiễm đường hô hấp.

Các bệnh tiêu chảy

- THƯỜNG GẶP SAU THẢM HỌA DO:
  - Cơ sở hạ tầng bị tàn phá diện rộng
  - Chất lượng nước không đảm bảo
  - Điều kiện vệ sinh thấp kém
  - Di chuyển nhiều người dân vào nơi ở sống tạm thời
  - Nhiều nguồn gây ô nhiễm thực phẩm và ô nhiễm nước

Phòng bệnh tiêu chảy, tả, lỵ, thương hàn

- Thực hiện đúng nguyên tắc ăn chín uống sôi.
- Không nên ăn rau sống, nếu ăn thì phải khử trùng bằng nước có pha chất khử trùng
- Uống hoặc tiêm các vaccin phòng bệnh khi có chỉ định.
- Cung cấp nước và thực phẩm đảm bảo
- Xử lý chất thải sau thảm họa

Xử lý các chứng tiêu chảy do nhiễm khuẩn:

+ Bù nước điện giải: bằng gói Oresol hoặc 1 lít nước sôi để nguội + 8 thìa nhỏ đường + 1 thìa nhỏ muối ăn.

+ Các kháng sinh.

Phòng bệnh đau mắt đỏ

- Viêm kết mạc cấp do vi khuẩn, vi rút do dùng nước bẩn.
- Không lau rửa mặt hoặc tắm bằng nước bẩn
- Không để trẻ em tắm gội, chơi đùa với nước bẩn.
- Rửa tay với nước sạch
- Không dùng chung khăn mặt, chậu rửa với người đang bị đau mắt đỏ.
- Chú ý diệt ruồi vì ruồi truyền bệnh đau mắt đỏ từ người bệnh sang người lành.

XỬ LÝ

- Dùng nước đun sôi để nguội, nước muối đẳng trương vô khuẩn để rửa mắt.
- Tra thuốc nhỏ mắt (Cloramphenicol 0,4%) cho tất cả những người có nguy cơ tiếp xúc với nước bẩn, dung dịch nhỏ mắt sun phát kẽm 1%, thuốc mỡ tetracycline 1%...

Phòng bệnh ngoài da do nước bẩn

- Không tắm gội và giặt quần áo bằng nước bẩn.
- Nếu không có nước giếng đã khử trùng thì phải đánh phèn hoặc lọc cát cho trong nước để tắm giặt.
- Không mặc quần áo ẩm ướt.
- Không để trẻ em bơi lội, tắm gội hoặc chơi đùa trong nước ngập lụt.
- Hạn chế lội vào chỗ nước bẩn tù đọng. Nếu phải lội, phải rửa ngay bằng nước sạch và lau khô, nhất là các kẽ ngón chân, ngón tay.

XỬ LÝ:

- Rửa sạch tay, chân, ngâm vào nước ấm có pha vài thìa muối ăn, lau khô các kẽ, các ngón.
- Bôi ngay thuốc đỏ hay thuốc sát trùng để phòng nước ăn chân: cồn iod 1%, dung dịch violet gentian, thuốc mỡ Whitfield (có các axit salycylic, axit benzoic)…

Nhiễm khuẩn đường hô hấp cấp

- Tăng nguy cơ viêm phổi do:
  - Đông người
  - Dễ nhạy cảm
  - Suy dinh dưỡng
  - Nơi ở tạm thời, điều kiện vệ sinh kém
- Nhiễm trùng cấp tính đường hô hấp trên
- Nhiễm trùng đường hô hấp dưới (viêm tiểu phế quản, viêm phổi): phải nhập viện

Xử lý các chứng viêm nhiễm đường hô hấp

- Phát hiện và quản lý sớm
- điều trị triệu chứng, kháng sinh.

5.2. Các bệnh lây truyền qua nước (do các vector trong nước)

Sốt rét và sốt xuất huyết

- Nguy cơ thường cao sau thảm họa (lũ lụt, sóng thần)
- Do tăng số lượng, loại vật chủ trung gian sống trong nước
- Muỗi sinh sản trở lại ngay sau khi nước bắt đầu rút.
- Dịch có thể xảy ra 4-8 tuần sau thảm họa

Phòng bệnh sốt rét, sốt xuất huyết

- Ngủ phải nằm màn
- Loại bỏ những vũng nước tù đọng là nơi sinh sản của muỗi.
- Phun hoá chất diệt côn trùng ở những nơi có nguy cơ cao hoặc khu vực có ổ dịch sốt rét, sốt xuất huyết.
- Thực hiện theo chương trình mục tiêu quốc gia

MƯỜI NHIỆM VỤ CẤP BÁCH CỦA Y TẾ TUYẾN TỈNH KHẮC PHỤC HẬU QUẢ LŨ LỤT

1. Hướng dẫn, vận động người dân ăn chín, uống sôi, dùng viên cloramin khử trùng nước trước khi dùng.

   Hướng dẫn cách pha hóa chất khử trùng, làm sạch môi trường, xử lý nước trên các phương tiện truyền thông đại chúng.

2. Nước rút đến đâu hướng dẫn làm sạch vệ sinh môi trường, thu gom, chôn rác, xác động vật.

3. Giám sát, quản lý các kho thuốc trừ sâu nếu có mất mát, phân tán ra xung quanh phải khoanh vùng xử lý.

4. Tăng cường quản lý chất lượng VSATTP, cấm việc bán thịt gia súc, gia cầm chết, giết mổ không hợp vệ sinh.

5. Kịp thời phát hiện và dập tắt dịch tiêu chảy, đau mắt đỏ, nước ăn chân, đề phòng dịch tả, lỵ, thương hàn, sốt xuất huyết, sốt rét…

6. Tổ chức phun hóa chất diệt muỗi ở vùng trọng điểm để phòng sốt xuất huyết, sốt rét.

7. Triển khai sử dụng các loại vắc xin phòng bệnh khi có chỉ định.

8. Khôi phục các cơ sở y tế: sửa chữa các nhà, trạm hỏng, nhanh chóng khôi phục hoạt động của cơ sở y tế.

9. Khôi phục các máy móc, thiết bị ở các cơ sở y tế.

10. Củng cố tủ thuốc thiết yếu, nhất là những nơi bị trôi, hư hỏng, ngập ướt, cung cấp đủ thuốc thiết yếu cho dân.

Kết luận

- Công tác VSMT cần đ□ợc tổ chức và quản lý chặt chẽ cả tr□ớc, trong và sau thiên tai.
- Đặc biệt trong điều kiện ngập lụt nếu không tổ chức quản lý và h□ớng dẫn kịp thời sẽ để lại hậu quả nặng nề
- Ngành y tế không thể làm thay nh□ng phải tham m□u cho chính quyền để tổ chức và h□ớng dẫn cho cộng đồng.